

SÍNCOPE — ESTRATIFICAR E DECIDIR

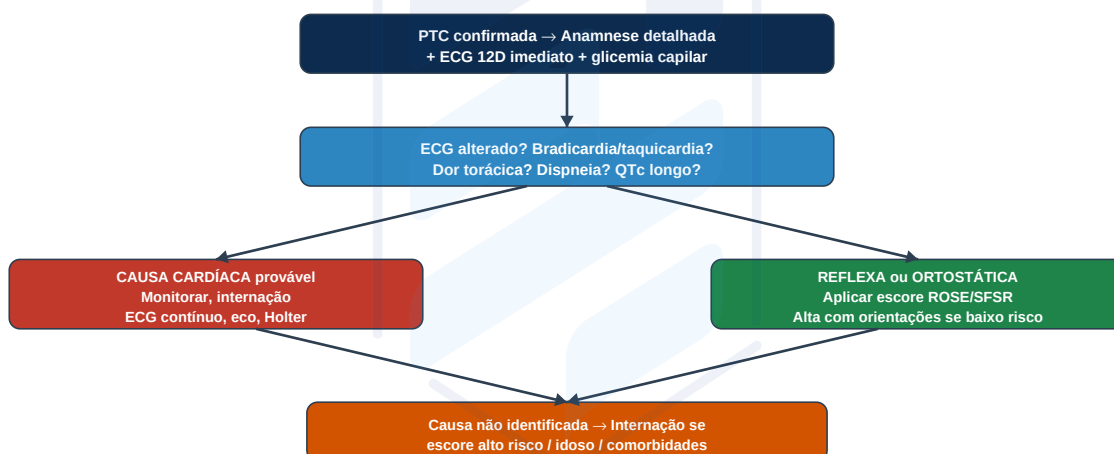
DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

O QUE É SÍNCOPE

- Perda transitória de consciência (PTC) por hipoperfusão cerebral global, curta duração, resolução espontânea
- Causas: reflexa/vasovagal (50%), cardíaca (15-25%), ortostática (10%), causa não identificada (~25%)
- Causa cardíaca = pior prognóstico: mortalidade em 1 ano até 30% se arritmica
- Diferenciar de: convulsão epiléptica, AIT, hipoglicemia, TCE, intoxicação (não são síncope)

AValiação Inicial — Diagnóstico

SÍNCOPE — ANAMNESE É FUNDAMENTAL



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL — 3 GRANDES GRUPOS

Tipo	Características	ECG / Exames
Reflexa (vasovagal)	Gatilho: dor, calor, ortostatismo prolongado, emoção. Pródromo: náusea, palidez, sudorese. Em pé. Jovens.	ECG normal; sem exame específico
Ortostática	Após levantar. PA cai $\geq 20/10$ mmHg em 3 min. Idosos, desidratação, medicamentos (anti-HP).	Medir PA deitado/em pé; hemograma
Cardíaca arritmica	Súbita, sem pródromo, em decúbito. Cardiopatia conhecida. ECG alterado. Qualquer postura.	ECG: BSA, BAVT, QTc longo, BRE novo; Holter; ECO
Cardíaca estrutural	Esforço, dispneia associada. EA, CMHO, TEP, dissecção.	ECO, D-dímero, TC se suspeita
NÃO-síncope (DD)	Convulsão: movimentos tônicos, confusão pós-ictal, mordicção. AIT: sem PTC. Hipoglicemia.	EEG, TC crânio, glicemia

ESCORE ROSE — ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

ALTO RISCO (≥ 1 critério = internar)

- BNP ≥ 300 pg/mL
- Bradiarritmia: FC < 50 , BSA, BAV 2º/3º grau
- Sangue oculto nas fezes positivo
- Anemia: Hb < 9 g/dL
- Saturação $< 94\%$ na admissão
- ECG: onda Q (infarto antigo)

SINAIS DE ALARME CARDÍACO — INTERNAÇÃO OBRIGATÓRIA

Achado	Conduta
BAVT/BAV 2ºG tipo II, BSA sintomático	Monitorar, MP transcutâneo standby, cardiologia
Taquicardia ventricular / FV	UTI, DAI, antiarrítmico
QTc > 500 ms (torsades)	Suspender drogas QT-longo, MgSO4 IV
Dissecção aórtica, TEP, estenose aórtica grave	TC angio, eco, cirurgia/hemodinâmica
Cardiopatía estrutural + síncope no esforço	Internação + eco + Holter + avaliação de DAI

EXAMES NA SÍNCOPE — O QUE PEDIR

AValiação mínima e dirigida

- ☐ ECG 12 derivações: OBRIGATÓRIO em TODOS (custo zero, alto rendimento)
- ☐ Glicemia capilar: descartar hipoglicemia (principal pseudossíncope)
- ☐ HAS ortostática: PA deitado e em pé (3 min): queda $\geq 20/10$ mmHg = positivo
- ☐ Hemograma + BNP: se escore ROSE / suspeita cardíaca / idoso
- ☐ Holter 24h ou loop recorder: síncope recorrente sem diagnóstico
- ☐ Eco: cardiopatía suspeita (sopro, IC, esforço). TC/RM: suspeita AVC/TCE, não de síncope pura
- ☐ NÃO pedir: EEG, TC, D-dímero de rotina sem indicação específica

CRITÉRIOS DE ALTA SEGURA

BAIXO RISCO — PODE DISPENSAR

- Jovem (< 40 anos), sem cardiopatía, primeiro episódio vasovagal clássico
- ECG normal, sem bradicardias, sem QTc longo
- Resolução espontânea, sem quedas com trauma
- Orientações: evitar gatilhos, hidratação, levantar devagar, meias elásticas
- Retorno se recorrência, palpitações, dor torácica ou presíncope frequente
- Acompanhamento com clínico/cardiologista em 1-2 semanas

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Qual das características abaixo é mais sugestiva de síncope de etiologia CARDÍACA em vez de vasovagal?

- A) Ocorre em ortostase prolongada com pródromo de náusea e palidez
- B) Gatilho emocional, jovem, em ambiente quente
- C) Súbita, sem pródromo, em decúbito, com cardiopatia conhecida
- D) Após levantar-se rapidamente em paciente idoso usando anti-hipertensivo
- E) Após doação de sangue com sudorese profusa

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com síncope e ECG mostrando QTc de 530 ms. Qual é a principal preocupação?

- A) Bloqueio AV de 1º grau
- B) Torsades de Pointes — risco de morte súbita
- C) Fibrilação atrial
- D) Extrassístolia atrial benigna
- E) Bradicardia sinusal assintomática

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Segundo o escore ROSE, qual achado isolado indica alto risco e necessidade de internação?

- A) Síncope ao levantar-se em paciente de 30 anos
- B) BNP ≥ 300 pg/mL
- C) ECG com PR de 220 ms
- D) Primeira síncope vasovagal em jovem
- E) Glicemia de 90 mg/dL

QUESTÃO 4

HCor / Adaptada

Quais exames são considerados obrigatórios na avaliação inicial de toda síncope no PS?

- A) TC de crânio e EEG
- B) ECG 12 derivações e glicemia capilar
- C) Holter 24h e ecocardiograma
- D) D-dímero e troponina de rotina
- E) Eletroencefalograma e BNP

QUESTÃO 5

CFM / Adaptada

Paciente de 70 anos, síncope ao esforço, com sopro sistólico importante em foco aórtico ao exame. O diagnóstico mais provável é:

- A) Síncope vasovagal clássica
- B) Hipotensão ortostática
- C) Estenose aórtica grave — síncope estrutural
- D) QT longo hereditário
- E) Síncope pós-prandial

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Síncope cardíaca arritmica: súbita, sem pródromo, pode ocorrer em decúbito, associada a cardiopatia conhecida. Vasovagal: ortostase prolongada, gatilho, pródromo autonômico (náusea/palidez/sudorese), resolução rápida.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

QTc ≥ 500 ms é marcador de risco para Torsades de Pointes (TV polimórfica em salvas), que pode causar síncope e morte súbita. Suspender drogas que prolongam QT, repor magnésio, cardiologia urgente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Escore ROSE: BNP ≥ 300 , bradicardia grave, sangue oculto +, Hb < 9 , SpO₂ $< 94\%$, onda Q = alto risco → internação. BNP elevado sugere disfunção ventricular e síncope cardíaca.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

ECG 12D e glicemia capilar são os dois exames iniciais obrigatórios: ECG identifica causas arritmicas com custo zero; glicemia descarta a principal pseudossíncope. TC e EEG não são de rotina.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Síncope ao esforço + sopro sistólico em aorta em idoso = estenose aórtica grave até prova em contrário. A EA causa síncope de esforço por incapacidade de aumentar o DC. Eco confirma. Prognóstico grave sem cirurgia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico